

TEMA 4.4 • DERMATOLOGÍA

Liquen Simple Crónico, Liquen Plano y Liquen Escleroso

PERFIL EUNACOM 6.01.1.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patologías Likenificantes y los Diferentes Líquenes

A pesar de que comparten el vocablo "Liquen" en su nomenclatura y se abordan usando antiinflamatorios esteroidales fuertes, conforman tres patologías etiológicamente absolutamente diferentes y dispares en su clínica y abordajes.

Contexto: ¿Qué es la liquenificación?

Corresponde a un **engrosamiento vasto cutáneo epidérmico acompañado con un acentuado marcado y exacerbación profunda del surco/dibujo de la piel**, luciendo clínicamente engrosada coréacea o acartonada. - De los tres líquenes, *sólo* el Simple Crónico sufre y presenta liquenificación de facto.

1. Liquen Simple Crónico (Neurodermatitis)

- **Etiología / Fisiopatología:** Mecánico-Conductual. Producto directo del letal ciclo hiperquinético **Prurito-Rasquido-Inflamación-Prurito**. Las garras rascadoras de las manos originan al liquen secundario en respuesta al rascado incesante. - **Cuadro Clínico Morfopatológico:** **Placa Pruriginosa y fuertemente Likenificada** (Piel de elefante engrosada en cuadrícula). - **Cartografía Típica:** Zonas de alto grataje. Cara posterior del Cuello, rebordes tobilleros en EEII inferior y fosas poplíteas/braquiales asediadas por atopias previas. Frecuente también de desarrollarse sobre lesiones previas preexistentes muy pruriginosas (Ej. rascarse una Tiña Cruris inguinal a destajo termina engendrando un Liquen Simple Crónico agrietado residual suprainpuesto). - **Manejo Integral:** 1. Mandamiento N°1: **Romper el Círculo de rascado (Prohibición estricta de grataje)**. 2. Tratar las patologías basales crónicas rascadas. 3. Desinflamar: **Corticoides Tópicos**. 4. Anti pruriginosos: Antihistamínicos Vía oral recetados para paliar el asedio irritante.

2. Liquen Plano

- **Etiología:** Desorden inmunológico **Patología Autoinmune Directa**. - **Cuadro Clínico Morfopatológico:** Patognomónicamente encarna y manifiesta semiológicamente la regla exclusiva de las "*Temidas 6 P*": **Pápulas, Pequeñas, Púrpuras, Poligonales, Pruriginosas que Brillan (ligeramente)**. (*Es fundamental advertir la diferencia con el Simple, ya que el Plano debuta no como Placa hiperqueratósica masiva, sino que con estas letales micro-pápulas púrpura brillante*). - **Cartografía Típica:** Su sitio clásico de asedio de las pápulas son las superficies de flexión directas de ambas **Muñecas de manos y Antebrazos**, como los tobillos en flectura. - **Microambiente en Mucosas (Sello Diferencial):** Frecuentemente en hasta un alarmante y revelador 50% de los afectados desarrolla un compromiso paralelo autoinmune perioral afectando a la **Mucosa Oral Yugular Interna las mejillas bucales**, produciendo el aspecto reticular y de araña estriado asintomático del esmalte oral (*Estrias de Wickham blanquecinas estrelladas*). - **Manejo Tratante:**

Corticoides Tópicos de Alta Potencia (ej: Clobetasol

Propionato/Betametasona). Con opciones remanentes a uso Inmunomodulador/Fototerapia si asedia sin tregua.

3. Liquen Escleroso (Escleroatrófico)

- **Etiología:** Patología celular inflamatoria **Autoinmune** degenerativa y localizada. - **Cuadro Clínico Destructivo Perineal:** Manifiesta a nivel basal de la entrepierna como una peligrosa y silente **Placa Pruriginosa de tez blanquecina Hipopigmentada de bordes pálidos nacarados e intensa atrofia celular cutánea superficial**. Ocasionalmente pueden volverse muy dolorosas. - **Cartografía Típica:** Sumamente confinada a las geografías genitales inferiores, preferentemente la **Vulva Femenina ginecológica (Labios Mayores / Menores / Zona Perianal)** o al forro cuticular del **Prepucio peneano en el Varón**. - **Complicaciones Estructurales a Larga Data:** Tiende a avanzar su destrucción atrófica disolviendo los márgenes y conformando deformaciones cicatrizales fibróticas adherentes genitales agudas crónicas. - **Tratamiento Puntero Freno Agudo:** Uso vital para aminorar de **Corticoides Tópicos Locales de Alta Potencia extrema de base**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál de los tres tipos de liquen tiene riesgo de transformarse en carcinoma espinocelular?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Liquen Simple Crónico, Liquen Plano y Liquen Escleroso. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El liquen simple crónico es un círculo vicioso de rascado que produce placa liquenificada en cuello y tobillos.
- El liquen plano autoinmune se recuerda con las seis P: púrpura, poligonal, pruriginoso, plano, brillante.
- El liquen plano afecta muñecas, antebrazos y tobillos, con compromiso oral reticular en el cincuenta por ciento.
- El liquen escleroso es autoinmune y produce placa blanquecina pruriginosa en genitales y zona perianal.
- El liquen escleroso tiene riesgo de transformación a carcinoma espinocelular si no se trata adecuadamente.
- El tratamiento del liquen plano y liquen escleroso son corticoides tópicos de alta potencia.
- El antihistamínico es clave en el liquen simple crónico para cortar el ciclo rascado-picazón.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LIQUEN SIMPLE CRÓNICO, LIQUEN PLANO Y LIQUEN ESCLEROSO)**PREGUNTA 1**

¿Cuál de los tres tipos de liquen tiene riesgo de transformarse en carcinoma espinocelular?

- A)** El liquen simple crónico de cuello y tobillos
- B)** El liquen plano oral de la mucosa yugal
- C)** El liquen escleroso genital y perianal
- D)** El liquen plano pigmentoso de la cara
- E)** El liquen simple crónico del cuero cabelludo

PREGUNTA 2

¿Cómo se recuerdan clásicamente las características del liquen plano?

- A)** Cuatro S: seco, sebáceo, simétrico y superficial
- B)** Las seis P: púrpura, poligonal, pruriginoso, plano, plano y brillante
- C)** El acrónimo ABCDE como en el melanoma maligno
- D)** El raspado de Brocq con tres signos sucesivos característicos
- E)** Las tres D: descamación, dolor y distribución flexora

PREGUNTA 3

¿Cuál es el mecanismo que perpetúa el liquen simple crónico?

- A)** La infección bacteriana crónica que mantiene la inflamación activa
- B)** El círculo vicioso de rascado, inflamación y picazón que se perpetúa a sí mismo
- C)** La respuesta autoinmune de linfocitos T contra queratinocitos basales
- D)** La colonización por hongos que producen irritación crónica perpetua
- E)** La exposición solar crónica que genera daño actínico acumulativo

RESUMEN: LIQUEN SIMPLE CRÓNICO, LIQUEN PLANO Y LIQUEN ESCLEROSO

Los tres tipos de liquen son enfermedades cutáneas con mecanismos y características clínicas distintas. El liquen simple crónico es consecuencia de un círculo vicioso de rascado, inflamación y picazón que lleva a una placa liquenificada con engrosamiento e hiperpigmentación de la piel, localizada preferentemente en cuello y tobillos, y se trata con corticoides tópicos más antihistamínicos para cortar el ciclo. El liquen plano es una enfermedad autoinmune con lesiones que clásicamente se recuerdan como las seis P en inglés: pápulas de color púrpura, poligonales, pruriginosas, planas y brillantes localizadas en muñecas, antebrazos y tobillos, con afectación de mucosa oral en forma reticular hasta en el cincuenta por ciento de los casos, y se trata con corticoides tópicos de alta potencia. El liquen escleroso también es autoinmune y produce una placa blanquecina pruriginosa en vulva, labios menores, zona perianal y prepucio, con riesgo de carcinoma espinocelular si no se trata, y el tratamiento es con corticoides tópicos de alta potencia como el clobetasol.